Wie bereite ich mich auf die Praxisbegehung vor?

Stefan Fritz

dedz MANNHEIM DEUTSCHES END- UND DICKDARM ZENTRUM

49. Deutscher Koloproktologen-Kongress, München, 18.03.2023

Herkunft des Begriffs „Hygiene“

Altgriechisch ὑγιεινή (hygieinḗ):

- „der Gesundheit dienend“

Aus griechischer Mythologie:

- Hygieia die Göttin der Gesundheit
- Tochter des Asklepios

„Lehre von der Gesunderhaltung sowohl des Einzelnen als auch der Allgemeinheit“



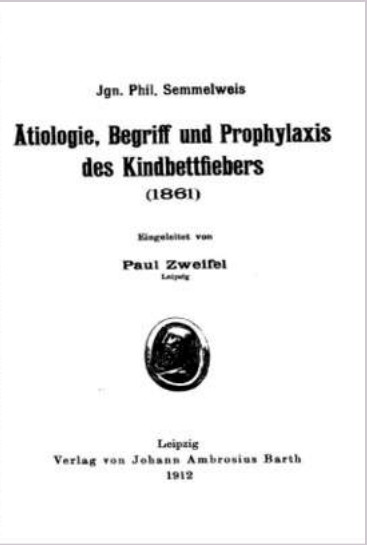
Statue der Hygieia,
ca. 130–160 v. Chr.
L.A. County Museum

Pfeifer W. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, Akademie-Verlag 1993

Hygiene in Krankenhäusern rettet Leben

Ignaz Semmelweis verminderte durch die Einführung der antiseptischen Prophylaxe die Sterblichkeitsrate in seiner Abteilung innerhalb von zwei Jahren von 12,2% auf 1,3%.





Bedeutung von Hygienebegehungen in der Arztpraxis

Wichtiger Bestandteil des Hygienemanagements in Praxen und Krankenhäusern

Hygienebegehungen sind in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben



Ziele:

- Sicherstellung von Hygienestandards
- Identifizierung von potenziellen Infektionsquellen
- Ergreifen von Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen
- Feststellung von Schulungsbedarf beim Personal

Häufige Fragen zum Thema Hygienebegehung

1. Wie oft ist eine Hygienebegehung notwendig?
    - **Interne Begehung** und Überprüfung der Dokumente mind. 1x/Jahr
    - **Externe Begehung** individuell verschieden, abhängig vom Infektionsrisiko
    - Unangekündigte Begehungen selten, nur wenn der V.a. Hygienemängel besteht

2. Wer sollte an der externen Begehung teilnehmen?
    - Praxisinhaber/-in
    - Hygienebeauftragte Person

3. Was wird bei der Hygienebegehung überprüft?
    - Es geht darum, den **IST-Zustand** einer Praxis mit dem **SOLL-Zustand** abzugleichen
    - Überprüft werden: **Arbeitssicherheit, Hygiene und Medizinprodukte**

4. Ist die Praxisbegehung kostenpflichtig?

Gesetzliche Grundlagen

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

- Es soll **übertragbare Krankheiten vorbeugen**, Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern
- Einhaltung von Hygienevorschriften und Durchführung von Hygienebegehungen



Medizinproduktegesetz (MPG)

- Soll für die Sicherheit, Eignung und Leistung von Medizinprodukten sorgen
- Einhaltung von Hygienevorschriften bei der **Aufbereitung von Medizinprodukten**

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

- Verpflichtet Arbeitgeber zur Bereitstellung von ausreichendem **Infektionsschutz für ihre Mitarbeiter**

Arzneimittelgesetz (AMG)

- Regelt den Verkehr mit Arzneimitteln zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und sicheren Arzneimittelversorgung

Normen und Richtlinien

Hygieneverordnung (HygV)

- Legt die Anforderungen an die Hygiene fest
- Regelt u.a. die Durchführung von Hygienebegehungen

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI)

- RKI: Zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention
- **KRINKO-Empfehlungen**: Infektionsprävention (z.B. zur Aufbereitung von Medizinprodukten oder Prävention noskomialer Infektionen)

Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetrV)

- Legt die Anforderungen an die Aufbereitung von Medizinprodukten fest



Robert Koch-Institut (RKI), Berlin



Quelle: ophardt.com

Weitere Verordnungen und Richtlinien

- TRBA 250 (Techn. Regel für biolog. Arbeitsstoffe)
- Biostoffverordnung (BioStoffV)
- Gefahrenstoffverordnung
- Trinkwasserverordnung (TrinkV)
- Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV)
- Röntgenverordnung
- Mess- und Eichgesetz
- Technische Regeln
- Qualitätssicherungsrichtlinien



Hygiene-Standards heute

„Grundsätzlich hat jeder Patient einen Rechtsanspruch darauf, dass alle Personen, denen er sich zur Behandlung anvertraut, die Standards der Infektionsverhütung nicht nur kennen, sondern sie auch einhalten!“



Quelle: www.bodymedia.de/news/bundestag

Quelle: A. Schneider, Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen 2021

Nichteinhaltung von Hygienestandards

„Der niedergelassene Arzt haftet für den Eintritt einer Infektion und deren Folgen, die auf die Verletzung der Hygiene-vorschriften zurückzuführen sind.“



Quelle: www.istockphoto.com

Landgericht München I, 7.7.2004 – 9 O 18834/00

Welche Behörden führen Begehungen durch?

- **Gesundheitsamt**
  Überwacht die Einhaltung der **Hygienevorschriften** und die Einhaltung des Infektionsschutzgesetztes
- **Gewerbeaufsichtsamt**
  Schwerpunkt: Überwachung der Einhaltung von **Arbeitsschutzvorschriften** aus der Perspektive der Medizinproduktebetreiberverordnung
- **Zuständiges Amt für Arbeitsschutz**
- **Berufsgenossenschaften für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege (BGW)**
- **In Ausnahmefällen die Kassenärztliche Vereinigung (KV)**



Je nach Zuständigkeit im Bundesland sind unterschiedliche Ämter berechtigt, Ihre Praxis zu begehen.

Mögliche Sanktionen bei Nichteinhaltung der Standards

1. Bußgeldverfahren
   - Es können Bußgelder gegen den/die Betreiber der Praxis verhängt werden



2. Sanktionen vonseiten der Krankenkassen
   - Die Krankenkassen können die Erstattung von Leistungen einschränken oder verweigern
3. Betriebsuntersagungen
   - Bei schweren Verstößen durch die zuständigen Behörden
4. Schadensersatzforderungen
   - Gegen die Einrichtung bei nachgewiesenen Infektionen aufgrund von Hygienemängeln

Allgemeine Vorbereitung der Hygienebegehung

1. Postalische Ankündigung und ggf. Anforderung von Unterlagen
2. Überprüfung aller hygienerelevanten Prozesse auf Aktualität

   Vorbegehung mit Hygienefachkräften oder speziellen Beratungszentren, z.B. **Deutsches Beratungszentrum für Hygiene (BZH)**, Rahmenvertrag mit dem Berufsverband

3. Bereithaltung relevanter Ordner und Daten

   Hygieneplan, Prozessbeschreibungen in der Praxis

4. Identifikation von Risiken und Schwachstellen
5. Überprüfung der Dokumentation

   Vollständigkeit der Schulungs- und Fortbildungsnachweise



Quelle: Miriam Dörr/fotolia

Allgemeine Hygienemaßnahmen

Bauliche Anforderungen an die Praxis

- Wartezimmer (Stühle abwischbar? Pflanzen? Dekoration?)
- Anmeldung (Sauberkeit, Datenschutz)
- Sanitärräume (Waschplätze, Müllentsorgung, Lüftung)
- Behandlungsräume (Waschbecken, Untersuchungsliegen)
- Labor (rein/unrein Trennung, Waschplatz, Arbeitsflächen)
- Putzraum (Regale, Putzutensilien), Lagerraum (Schränke)
- Fußböden (Bodenbeläge, Teppichboden)



Quelle: www.praxisgestalter.de

Hygieneplan (nach Kassenärztlicher Bundesvereinigung KBV)

- Händehygiene, Haut- und Schleimhautantiseptik
- Flächenreinigung- und Desinfektion
- Reinigung und Desinfektion von medizinischen Geräten
- Umgang mit Medikamenten
- Persönliche Schutzmaßnahmen
- Aufbereitung von Medizinprodukten
- Abfallentsorgung



Spezielle Tipps zur Vorbereitung der Hygienebegehung

Erstellung einer Checkliste



- Relevante Prozessbeschreibungen
- Schulungs- und Fortbildungsnachweise

Planung der Begehung

- Wer soll an der Begehung teilnehmen?
- Alle relevanten Bereiche sollten abgedeckt sein
- Besondere Berücksichtigung der Risikobereiche, z.B. Sterilisation von Instrumenten, Händehygiene, Reinigung von Flächen und Gegenständen

Selbstauskunft vor geplanter externer Begehung

- Oftmals werden zunächst die Unterlagen zur Vorbereitung angefordert
- In manchen Fällen wird daraufhin die Begehung durch die Behörde abgesagt

Kompetenzzentrum Hygiene und Medizinprodukte (CoC)

Bogen zur „Feststellung des Status quo in der Arztpraxis“



Kompetenzzentrum
Hygiene und Medizinprodukte
der KV'en und der KBV

Hygiene und Medizinprodukte -
Feststellung des Status quo in der Arztpraxis

Erhebungsbogen

Datum der Erhebung: ☐

Erhebung durch: ☐

Organisatorische Voraussetzungen

1. Alle Beschäftigten werden mindestens einmal jährlich in den Hygieneplan und in den Umgang mit Gefahr- und Biostoffen unterwiesen. *Zu den Erläuterungen* **Bemerkungen:**	☐ ja ☐ nein ☐ teilweise
2. Die Beschäftigten sind durch Fortbildungen und Schulungen auf dem aktuellen Stand der relevanten hygienischen Maßnahmen. *Zu den Erläuterungen* **Bemerkungen:**	☐ ja ☐ nein ☐ teilweise
3. Beschäftigte, die semikritische und kritische Medizinprodukte aufbereiten, verfügen über eine entsprechende Qualifikation. *Zu den Erläuterungen* **Bemerkungen:**	☐ ja ☐ nein ☐ teilweise
4. Das Verfahren zur Übermittlung meldepflichtiger Erkrankungen ist schriftlich festgelegt. *Zu den Erläuterungen* **Bemerkungen:**	☐ ja ☐ nein ☐ teilweise

Kostenfreier **Download** unter

https://www.hygiene-medizinprodukte.de/download

Hier finden Sie folgende Dokumente des CoC:

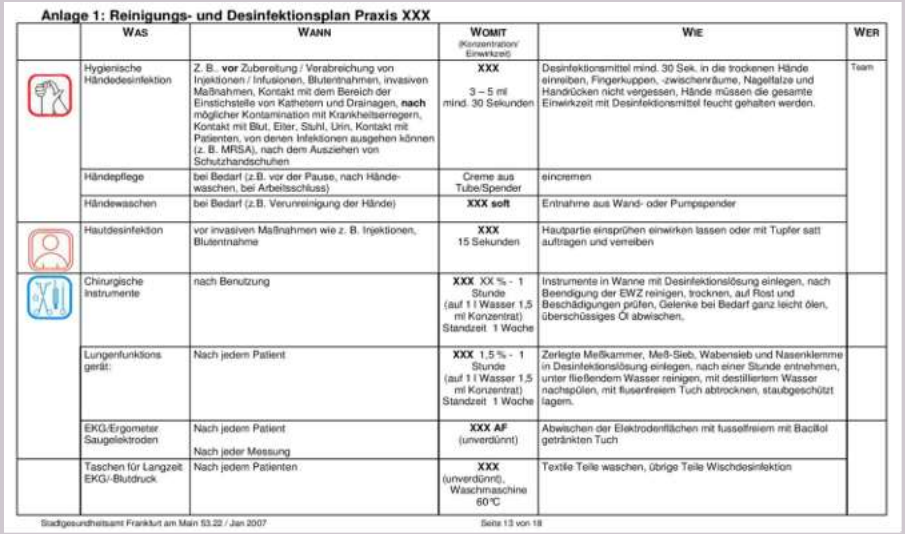
- Status quo in der Arztpraxis (2015, 2017)
- Hygieneleitfaden - Arztpraxis (2014, 2019)

Die Erstellung eines Hygieneplans ist Pflicht!

- Individuelle Festlegung der **innerbetrieblichen Verfahren** zur Infektionshygiene
- **Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung** schriftlich festzulegen
- Gilt als **Dienstanweisung für alle Mitarbeiter**, muss von dem Leiter der Einrichtung unterschrieben sein und die Kenntnisnahme von allen Mitarbeitern (Reinigungskräfte nicht vergessen) gegengezeichnet werden
- Muss für alle Beschäftigten **jederzeit zugänglich** und einsehbar sein

IfSG §36; TRBA 250 4.1.2.3.

Erstellung des Hygieneplans



Anlage 1: Reinigungs- und Desinfektionsplan Praxis XXX

	Was	Wann	Womit (Konzentration/ Einwirkzeit)	Wie	Wer
	Hygienische Händedesinfektion	Z. B.. **vor** Zubereitung / Verabreichung von Injektionen / Infusionen, Blutentnahmen, invasiven Maßnahmen, Kontakt mit dem Bereich der Einstichstelle von Kathetern und Drainagen, **nach** möglicher Kontamination mit Krankheitserregern, Kontakt mit Blut, Eiter, Stuhl, Urin, Kontakt mit Patienten, von denen Infektionen ausgehen können (z. B. MRSA), nach dem Ausziehen von Schutzhandschuhen	**XXX** 3 – 5 ml mind. 30 Sekunden	Desinfektionsmittel mind. 30 Sek. in die trockenen Hände einreiben, Fingerkuppen, -zwischenräume, Nagelfalze und Handrücken nicht vergessen, Hände müssen die gesamte Einwirkzeit mit Desinfektionsmittel feucht gehalten werden.	Team
	Händepflege	bei Bedarf (z.B. vor der Pause, nach Händewaschen, bei Arbeitsschluss)	Creme aus Tube/Spender	eincremen	
	Händewaschen	bei Bedarf (z.B. Verunreinigung der Hände)	**XXX soft**	Entnahme aus Wand- oder Pumpspender	
	Hautdesinfektion	vor invasiven Maßnahmen wie z. B. Injektionen, Blutentnahme	**XXX** 15 Sekunden	Hautpartie einsprühen einwirken lassen oder mit Tupfer satt auftragen und verreiben	
	Chirurgische Instrumente	nach Benutzung	**XXX** XX %ig - 1 Stunde (auf 1 l Wasser 1,5 ml Konzentrat) Standzeit 1 Woche	Instrumente in Wanne mit Desinfektionslösung einlegen, nach Beendigung der EWZ reinigen, trocknen, auf Rost und Beschädigungen prüfen, Gelenke bei Bedarf ganz leicht ölen, überschüssiges Öl abwischen.	
	Lungenfunktionsgerät:	Nach jedem Patient	**XXX** 1,5 %ig - 1 Stunde (auf 1 l Wasser 1,5 ml Konzentrat) Standzeit 1 Woche	Zerlegte Meßkammer, Meß-Sieb, Wabensieb und Nasenklemme in Desinfektionslösung einlegen, nach einer Stunde entnehmen, unter fließendem Wasser reinigen, mit destilliertem Wasser nachspülen, mit flusenfreiem Tuch abtrocknen, staubgeschützt lagern.	
	EKG/Ergometer Saugelektroden	Nach jedem Patient Nach jeder Messung	**XXX AF** (unverdünnt)	Abwischen der Elektrodenflächen mit fusselfreiem mit Bacillol getränkten Tuch	
	Taschen für Langzeit EKG/-Blutdruck	Nach jedem Patienten	**XXX** (unverdünnt), Waschmaschine 60°C	Textile Teile waschen, übrige Teile Wischdesinfektion	

Stadtgesundheitsamt Frankfurt am Main 53.22 / Jan 2007 Seite 13 von 18

Muster eines Hygieneplans

Der Plan sollte folgendes enthalten:

- Regelungen zur Händehygiene, Haut- und Schleimhautantiseptik
- Flächenreinigung- und Desinfektion
- Reinigung und Desinfektion von medizinischen Geräten
- Umgang mit Medikamenten
- persönliche Schutzmaßnahmen
- Aufbereitung von Medizinprodukten
- Abfallentsorgung

Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV

➢ Kostenfreier **Download:**
Mustervorlage Hygieneplan für die Arztpraxis (2017)

https://www.hygiene-medizinprodukte.de/download

Durchführung der Hygienebegehung

1. Vorgespräch mit den verantwortlichen Personen
   - Befragung zu Leistungen und Prozessabläufen in der Praxis
   - Besprechung besonderer Vorkommnisse



2. Begutachtung der gesamten Praxis
   - Überprüfung auf Sauberkeit während des Betriebs
   - Desinfektion von Räumlichkeiten, Möbeln und Geräten

3. Kontrolle der Einhaltung der Hygienestandards
   - Verhaltensweisen des Personals (z.B. Händehygiene)
   - Hygienemaßnahmen bei der Untersuchung der Patienten
   - Reinigung und Desinfektionsmaßnahmen

4. Überprüfung der Sterilisation der Geräte und Instrumente
   - Überprüfung der Regelmäßigkeit mit entsprechender Dokumentation
   - Einhaltung von Verfallsdaten von Desinfektionsmitteln und Sterilisationsverfahren

Nachbereitung der Hygienebegehung

1. Abschlussgespräch mit Praxisinhaber/-in

2. Auswertung der Ergebnisse
   - Festhaltung der Mängel in Protokollen (eigenes!)
   - Beratung und Empfehlungen



Quelle: www.medic-star.de

3. Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen
   - Erstellung eines Maßnahmenplans
   - Erstellung eines Zeitplans unter Einhaltung der gesetzten Fristen
   - Regelmäßige Überprüfung der Umsetzung der Empfehlungen und Maßnahmen

4. Nachbegehung, falls erforderlich

5. Vorbereitung der nächsten Hygienebegehung
   - Aktualisierung des Hygieneplan

Häufige Mängel bei der Hygienebegehung I

Hygieneplan nicht aktuell

Mängel bei der Händehygiene

- z.B. Tragen von Schmuck an den Händen (auch Uhren)
- Lackierte oder künstliche Fingernägel



Quelle: www.shein.com

Mängel bei der Flächendesinfektion

- Falsches Ansetzen von Desinfektionslösungen
- Vorgaben zur Flächendesinfektion nicht im Hygieneplan

Mängel bei der Aufbereitung von Medizinprodukten

- Unzureichender Wechsel der Reinigungs- und **Desinfektionslösung**
- Keine Trennung von **reinem und unreinem** Arbeitsbereich
- Fehlender Sachkundenachweis oder **fehlende Validierung** bei interner Aufbereitung
- Nicht vorhandene **Risikoeinstufung** von Medizinprodukten
- **Dokumentation** der Aufbereitung ist lückenhaft

Häufige Mängel bei der Hygienebegehung II

Mängel beim Umgang mit Medikamenten

- Keine Dokumentation von Anbruch- und Verfallsdatum
- Mehrfachentnahme aus Lösungen ohne Konservierungsstoffe (z.B. NaCl)
- Keine Trennung von Medikamenten und Lebensmittel im **Kühlschrank**



Räumlichkeiten

- Gemeinsame Lagerung von **Dienstkleidung und Privatkleidung**
- Verkalkung von Wasserhähnen, fehlender Spritzschutz an Wasserbecken
- Arbeitsflächen oder der Fußboden sind zugestellt oder verstaubt



Mängel beim Impfschutz des Personals

Verantwortliche Ansprechpartner bei Begehung nicht verfügbar

Beispiele für Mängel bei der Hygienebegehung







Tipps aus eigener Erfahrung I

Risikobewertung und Einstufung aufzubereitender Medizinprodukte

- Auflistung aller, auch der „unkritischen“ Medizinprodukte
- Zuordnung der Medizinprodukte mit Artikelnummer und Hersteller
- Dokumentation der kritischen Verfahrensschritte
- Listung der Einmalprodukte mit dem Hinweis auf die einmalige Verwendung und das Verbot der Aufbereitung

Mikrobiologische Prüfungen

- Vierteljährliche mikrobiologische Kontrollen der Endoskope
- Erstellung einer Verfahrensanweisung gemäß RKI-Richtlinien

Schulung und Fortbildung von Personal

- Sachkundige Mitarbeiter/-innen sollten das Personal mindestens jährlich schulen
- Regelmäßige interne und externe Schulungen

Tipps aus eigener Erfahrung II

Räume

- Entsprechende Beschilderung der Türen
- Aufbewahrung von Ordnern in geschlossenen Schränken
- Trennung von **unreinen und reinen** Abschnitten
- Keine Pflanzen mit **Blumenerde**



Reinigung und Desinfektion

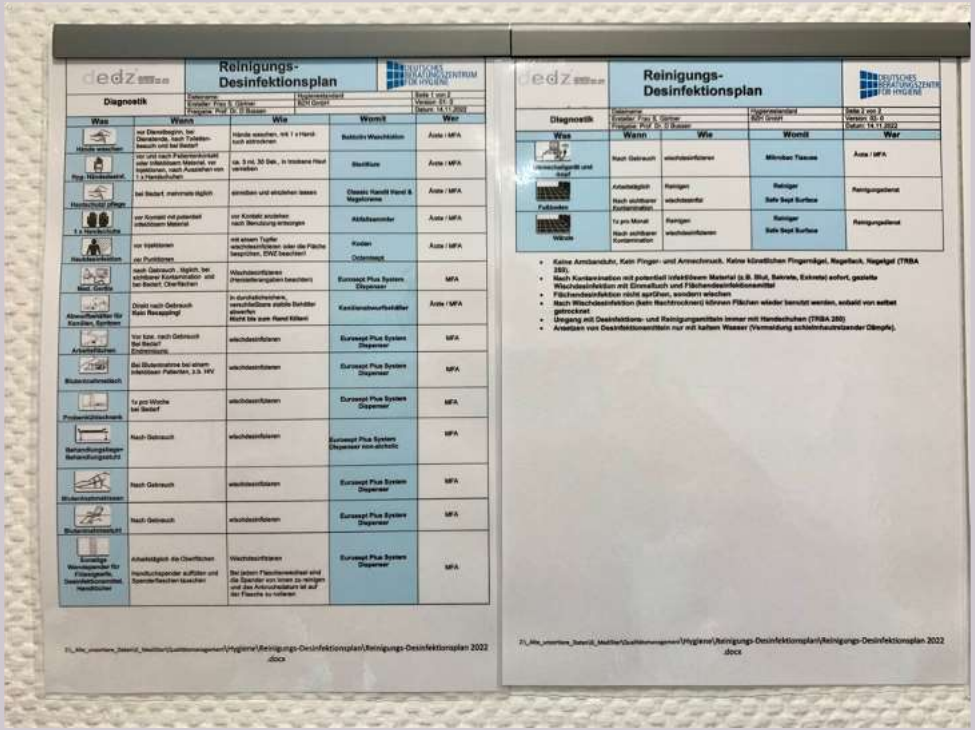
- Welche Reinigungsmittel sind für welche Produkte geeignet
- Anbruchsdatum auf den Kanistern dokumentieren



Sterilisation

- Auskühlzeit in einer sogenannten klaren Zone (Auskühlzone) beachten
- Die Freigabe der sterilisierten Medizinprodukte ist anhand eines Chargendokuments durchzuführen und zu dokumentieren.

Aushänge in den Behandlungszimmern



Reinigungs- und Desinfektionsplan



Händedesinfektion

Wie kann die Praxis von der Hygienebegehung profitieren?

Verbesserung der innerbetrieblichen Prozesse

- Fachlicher Austausch zwischen MFAs und Ärzten/-innen
- Rahmen für Diskussion über Optimierungsmöglichkeiten

Regelmäßige Begehungen

- Kontinuierliche Verbesserung der Prozessabläufe
- Ersparen von Arbeit und Stress bei festgelegten Terminen

Konstruktiver Austausch mit den Prüfern

- Verbesserung der Hygiene
- Erfahrungsaustausch
- Welche Lösungen haben andere Praxen gefunden?



Quelle: www.zeit.de/wissen/gesundheit

Fazit

- Die Anforderungen an die Hygiene in Praxen ist groß
- Hygienebegehungen dienen der Gesundheit der Patienten und dem Schutz des Personals
- Hygienebegehungen gesetzlich vorgeschrieben, können bei schwerwiegenden Mängeln relevante Folgen nach sich ziehen
- Hygienebegehungen können konstruktiv genutzt werden, um Prozesse zu optimieren

Viel Erfolg bei der Praxisbegehung!



Max von Pettenkofer
Chemiker/Hygieniker
1818-1901

„Die Kunst zu heilen kann viele Leiden lindern, doch schöner ist die Kunst, die es versteht, die Krankheit am Entstehen schon zu hindern.“

dedz MANNHEIM DEUTSCHES END- UND DICKDARM ZENTRUM